

Historial Clinico - P001

Psiquiatria - Dr. Francisco Morales Jimenez - Granada

1. Datos del paciente

ID Paciente	P001
NHC	NHC-2020-014832
Nombre completo	Carmen Ruiz Velasco
Sexo	Mujer
Fecha nacimiento	08/05/1981
Edad	45 anos
DNI	75.123.648-T
Telefono	658 412 093
Municipio	Granada
Medico responsable	Dr. Francisco Morales Jimenez
Especialidad	Psiquiatria

2. Antecedentes personales

- Trastorno depresivo mayor, episodio recurrente, gravedad moderada (diagnostico 2018, CIE-10: F33.1)
- Trastorno de ansiedad generalizada (diagnostico 2019, CIE-10: F41.1)
- Insomnio cronico de mantenimiento
- Migranas sin aura episodicas (desde 2010)
- Antecedente de ideacion autolitica pasiva en 2021, sin tentativas previas
- No alergias medicamentosas conocidas

Antecedentes familiares: Madre: trastorno depresivo mayor, en tratamiento desde los 50 anos. Padre: trastorno por consumo de alcohol, fallecido por cirrosis hepatica a los 64 anos. Hermana mayor: trastorno de ansiedad generalizada diagnosticado.

3. Historia clinica actual

Paciente de 45 anos derivada desde Atencion Primaria por empeoramiento clinico progresivo en las ultimas 10 semanas. Refiere estado de animo deprimido persistente con anhedonia marcada: ha dejado de salir con amigas, abandono el gimnasio al que acudia tres veces por semana y apenas se relaciona con sus hijos adolescentes. Presenta insomnio de mantenimiento con despertares a las 3-4 de la madrugada sin capacidad de reconciliar el sueno, fatiga diurna intensa, dificultad de concentracion que le ha llevado a cometer errores en su trabajo como administrativa en una gestoria, y sentimientos de inutilidad y culpa excesiva centrados en la crianza de sus hijos. Perdida de apetito con descenso ponderal de 4 kg en los ultimos 2 meses. Niega ideacion autolitica activa en el momento actual, aunque reconoce pensamientos recurrentes de que 'no sirvo para nada y mis hijos estarian mejor sin mi'. Concomitantemente refiere preocupacion excesiva e incontrolable por la economia familiar, la salud de su madre y el rendimiento escolar de sus hijos desde hace mas de 8 meses, con tension muscular cervical constante, inquietud motora y sensacion de nudo en el estomago permanente. Tratamiento previo con paroxetina 20 mg que interrumpio por decision propia hace 5 meses alegando 'ya me encontraba bien'. Las migranas han aumentado en frecuencia coincidiendo con el empeoramiento animico (de 2-3/mes a 6-8/mes).

4. Exploracion

Aspecto general	Consciente, orientada en las tres esferas. Aspecto cuidado pero con ojeras marcadas. Contacto visual intermitente
-----------------	--

Psicomotricidad	Enlentecimiento psicomotor leve. Latencia de respuesta aumentada. Suspiros frecuentes
Estado de animo	Animo deprimido. Afecto constrenido con llanto contenido durante la entrevista al hablar de sus hijos
Pensamiento	Curso enlentecido. Contenido con ideas de inutilidad, culpa y autorreproche. Rumiasiones ansiosas persistentes. Sin ideacion delirante
Sensopercepcion	Sin alteraciones. Niega alucinaciones auditivas o visuales
Cognicion	Atencion disminuida. Concentracion pobre, refiere 'leer la misma pagina cinco veces'. Memoria conservada
Juicio y conciencia de enfermedad	Juicio conservado. Conciencia de enfermedad parcial: reconoce que esta mal pero infravalora la gravedad
Riesgo autolitico	Ideacion pasiva de muerte sin planificacion ni intencion. Sin plan estructurado. Factores protectores: hijos menores
Peso / Talla / IMC	59 kg - 164 cm - 21,9 kg/m2
Tension arterial	122/76 mmHg
Frecuencia cardiaca	80 lpm, ritmica

5. Tratamiento actual

Farmaco	Posologia
Escitalopram 10 mg	1 comp. en desayuno (inicio reciente, pendiente de titular a 20 mg en 2 semanas)
Mirtazapina 15 mg	1 comp. en cena (coadyuvante para insomnio y apetito)
Lorazepam 1 mg	1 comp. en cena si ansiedad intensa (uso puntual, maximo 4 semanas)
Sumatriptan 50 mg	1 comp. al inicio de la migraña (maximo 2 dosis/semana)

6. Resultados de laboratorio

Parametro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
TSH	3,2 mU/L	0,4-4,0	Normal	2,9 mU/L
T4 libre	1,1 ng/dL	0,8-1,8	Normal	1,2 ng/dL
Hemograma	Normal	-	Normal	Normal
Glucosa	91 mg/dL	70-110	Normal	88 mg/dL
Cortisol (8h)	24,1 mcg/dL	6,0-18,0	Alto	-
Vit. B12	285 pg/mL	200-900	Normal	-
Acido folico	3,8 ng/mL	3,0-17,0	Normal	-
Ferritina	32 ng/mL	20-200	Normal	-
Perfil hepatico	Normal	-	Normal	Normal

7. Plan de actuacion

1. Titular escitalopram a 20 mg/dia en 2 semanas si buena tolerancia
2. Mantener mirtazapina 15 mg; valorar aumento a 30 mg si persiste insomnio de mantenimiento

3. Retirada progresiva de lorazepam en maximo 4 semanas
4. Derivacion a Psicologia Clinica para terapia cognitivo-conductual (TCC) semanal
5. Registro diario de migranas para valorar relacion con estado animico y posible profilaxis
6. Plan de seguridad: contacto telefonico con la consulta en 2 semanas. Acudir a urgencias si ideacion autolitica activa
7. Revision presencial en consulta en 4 semanas

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.